

Clinica de Diagnostic Gral

Str Traian Popovici Nr 79-91 Sector 3 Bucuresti Tel: 021-323.00.00 Fax: 021-323.00.00

RAPORT MEDICAL

Cod Document

RM15883577

Nume pacient IOVAN CORNELIA

Varsta 49 ani, 5 luni

CNP pacient 2751120441514

Sex Feminin

Loc executie Clinica de Diagnostic Gral

Adresa pacient

Data 27.03.2025 13:54

Telefon pacient 0722562366

Medic trimittator La cererea pacientului

Cod pacient 2268478

Medic executant ANGHEL RODICA

Nr. reg.

Istoric, antecedente, simptome

prima prezentare

Examen clinic, investigatii

CT cap + tap cu s.c./ IMAMED / 30.12.2024

In etajul cerebral:

- fara prize de contrast patologice intranevraxiale sau leptomeningeale
- fara leziuni cu alura ischemica recenta la nivelul parenchimului cerebral supra si infratentorial.
- fara acumulari hemoragice intra sau extranevraxiale.
- structurile liniei mediane nedeviate.
- sistem ventricular normal dimensional, simetric.
- santuri corticale, spatii lichidiene pericerebrale cu dimensiuni pastrate.
- sinusuri nazale si paranasale normal pneumatizate
- hipertrofia cometelor nazale inferioare.
- fara modificari de structura osoasa la nivelul calotei craniene si bazei craniului.

In etajul toraco-abdomino-pelvin:

- formatiune tumorala mamara dreapta, dispusa periferic in CSE, de cca. 23/24 mm-leziune neoplazica recent dg. HP: distorsiunea arhitecturala gadolinofila descrisa IRM in CII SD, nu este vizibila CT (limitele metodei).
- fara adenopatii tumorale axilare sau mamare interne, bilateral.
- plamani normal expansionati la peretele toracic.
- fara leziuni nodulare cu aspect secundar sau procese de consolidare pulmonara, la nivelul ambelor hemitorace.
- micronodul pulmonar interstitial nespecific, dispus periferic apico-dorsal in LSD, de cca. 3 mm, probabil cu substrat inflamator cronic-eventual, de monitorizat imagistic la distanta.
- arbore traheo-bronsic normal conformat.
- artere pulmonare si Ao toracica de calibru normal, omogen opacifiate postcontrast.
- fara adenopatii mediastinale sau hilare pulmonare, bilateral.
- fara acumulari fluide pleurale sau pericardice.
- densificarea tesutului celulo-grasos de la nivelul lojei timice, probabil in context reactiv.
- ficat normal dimensional, cu contur net si iodofilie omogena.
- fara dilatatii de CBIH/CBP.
- ax venos spleno-portal de calibru normal, omogen opacifiat.
- colecist cu pereti de grosime normala, fara imagini de calculi hiperdensi.
- splina fara modificari dimensionale, cu structura omogena.
- pancreas normal dimensional, cu structura acinara pastrata, fara leziuni focalizate intraparenchimatoase; duct Wirsung nedilatat.
- glande suprarenale cu aspect si morfologie in limite normale, cu exceptia unui nodul adenomatos suprarenalian stang de cca. 19 mm.
- ambii rinichi cu dimensiuni normale, buna diferentiere cortico-medulara, secretie si excretie prezente (simetric bilateral), fara dilatatii de SPC sau imagini de calculi; cateva chisturi corticale vizibile renal bilatreal, incadrabile Bosniak I, de maxim 7 mm in dreapta si 13 mm in stanga.
- fara adenomegalii subdiafragmatice cu caracter patologic.
- fara lichid de ascita.
- vezica urinara in semirepletie, cu continut omogen si pereti supli.
- uter in AVF, latero-deviat dreapta, cu axul lung de 90 mm, contur net si miometru neomogen, in context fibromatos (leziuni leiomiomatoase intramurale si subseroase corporeo-fundice, de maxim 40 mm antero-lateral dreapta la nivel corporeal); endometru de grosime normala si col uterin fara modificari dimensionale, cu contur net, dar cu cateva imagini ovulare hipocaptante, probabil chisturi Naboth (max. 18-19 mm) ambele anexe cu aspect si morfologie CT in limite normale (mic chist luteal aneural drept, de cca. 9 mm).
- fara ingrosari parietale focale suspecte la nivelul cadrului colic.

-fara leziuni osteocondensante sau osteolitice suspecte, la nivelul segmentelor osoase examinate.

Concluzii:

Formatiune tumorală mamară dreaptă, cu caractere de malignitate (confirmată HP), fără adenopatii tumorale axilare asociate.

În rest, aspect CT toraco-abdomino-pelvin și cranio-cerebral fără leziuni focalizate cu viza oncologică (fără leziuni cu substrat secundar).

RMN sani cu s.c. / Regina Maria / 27.12.2024

Sani cu structură glandulară heterogenă și încărcare parenchimatoasă de fond moderată, cu câteva prize de contrast tip focus (< 5 mm) și plaje focale hipercaptante, aleator dispersate mamar bilateral (cel mai probabil hormonal dependente).

Priza de contrast nodulară, cu contur microspiculat, vizibilă medioglandular în CSE SD, la cca. 5 cm de mamelon, de aprox. 26/23 mm, cu restricție de difuzie prezintă și gadolinofilie heterogenă, predominant periferică, de tip inelar, intensă inițial, ulterior cu wash-out (curba tip III), având caractere IRM de malignitate, reprezentând corespondentul leziunii neoplazice recent dg. HP.

Mica distorsiune arhitecturală gadolinofilă, vizibilă în CII SD, la cca. 4-4,5 cm de mamelon și 4 cm de m. pectoral, aprox. ora 5.30-6, ce își crește aria de proiecție pe ultimele scanări efectuate postcontrast, de cca. 9/8,5 mm, cu caractere IRM ușor suspecte, încadrabile BIRADS 4a, ce ar putea reprezenta corespondentul distorsiunii arhitecturale descrise în CII, la evaluarea ecografică prebiptică.

Fără prize de contrast tip masă sau distorsiuni arhitecturale suspecte pentru neoplazie, mamar în stângă.

Câteva leziuni chistice izolate sau grupate, unele septate, aleator dispersate mamar bilateral, de maxim 6 mm în CSE SD și 4 mm la unirea cadranelor superioare SS.

Fără adenopatii tumorale axilare sau în grupele mamare interne bilaterale.

Concluzii:

Anomalie mamară dreaptă dispusă medioglandular în CSE, cu caractere IRM de malignitate, reprezentând corespondentul leziunii neoplazice recent dg. HP.

Distorsiune arhitecturală gadolinofilă, dispusă medioglandular în CSE, cu caractere IRM de malignitate,

Anomalie mamară dreaptă dispusă medioglandular în CSE, cu caractere IRM de malignitate, reprezentând corespondentul leziunii neoplazice recent dg. HP.

Distorsiune arhitecturală gadolinofilă, dispusă medioglandular în CII SD, spre unirea cadranelor inferioare, cu caractere IRM ușor suspecte, reprezentând cel mai probabil corespondentul distorsiunii arhitecturale descrise ecografic, la evaluarea prebiptică.

Câteva leziuni chistice izolate sau grupate, unele septate, aleator dispersate mamar bilateral.

IRM BIRADS SD: 6

IRM BIRADS SS: 2

Mamografie bilaterală / Regina Maria / 12.12.2024

San drept

În periferia glandei, cadran SE (aprox 60mm distanță de mamelon și 11 mm de tegument) decelează asimetrie de densitate discret retractilă cu aspect chiar nodular, neomogenă cu contururi angulate chiar spiculate pe MLO ce masoară 20/24 mm. Central la nivelul acesteia focar ovalar de microcalcificări i vermiculare. Complexul lezional are caractere mamografice incerte, înalt suspecte pentru malignitate câteva microcalcificări izolate, dispersate cu caractere benign mamografic

San stâng:

câteva fine calcificări puncte, izolate- benigne mamografic

Fără opacități spiculate sau focare de microcalcificări patologice.

Fără imagini de distorsiuni arhitecturale

San drept - anomalie cu caractere incerte, înalt suspecte pentru malignitate

CONCLUZII:

Fără anomalii mamografice suspecte pentru neoplazie mamară san stâng.

BI-RADS: SD 5 SS 2

Diagnostic

Neoplasm mamar drept bp 12.2024, operat 03.2025 pT2(2), N1a, LVI+, Pn+, RO, ER=95%, PR=45%, Her2 neg, ki67=20%

-mutație cu BRCA 2 cu semnificație patogenică

BHP-IHC nr.224454 / Oncoteam / 05.03.2025

Examinare macroscopică:

1 : Tesut adipos de 3/2/1 cm ce înglobează 3 limfoganglioni, cel mai mare de 1,5 cm - limfoganglionii se includ în 2 blocuri de parafină.

2: Fragmente albicioase ce masoară cumulativ 3/3/0,5 cm - se include integral în 3 blocuri de parafină.

3: Piesa de excizie de 19/18/3 cm cu mic lambou cutanat de 7/2 cm in cadranul supero-extern, subiacent caruia se deceleaza formatiune tumorală de 2,5/2,5/2,8 cm, se afla la 6 cm de medial si la 4 cm de lateral, 8 cm de inferior si la 2,5 cm de superior, 1 cm de anterior si 0,5 cm de profund - se includ sectiuni in 12 blocuri de parafina.
4: Piesa de excizie de 13/14/15 cm, fara leziuni macroscopice decelabile - se includ sectiuni in 6 blocuri de parafina.
5: Tesut adipos de 7/7/3 cm ce inglobeaza limfoganglioni - se includ in 7 blocuri de parafina.

Piesa 1

224454/1: 1 limfoganglion in doua transe - extemporaneu

224454/2: 2 limfiganglioni in doua transe

Rezerva tesut adipos

Piesa 2

224454/3-4: extemporaneu

224454/5: rest tesut

Inclus integral

piesa 3:

224454/6: limita laterala

224454/7: limita superioara

224454/8: formatiune tumorală cu tegument si limita anterioara

224454/9-11: formatiune tumorală (10,11 cu limita profunda)

224454/12-15: formatiune tumorală (14,15 cu limita profunda)

224454/16-17: formatiune tumorală

Rezerva.

Piesa 4

224454/18-19: limitele laterala si mediana

224454/20-23: placarde mastozice cu limita inferioara, anterioara, superioara si profunda

Rezerva

Piesa 5:

224454/24-26: limfoganglioni

224454/27: 2 limfoganglioni in doua transe

224454/28: limfiganglioni

224454/29-30: 2 limfoganglion in transe multiple

Rezerva tesut adipos.

Se reorienteaza macroscopic piesa, si se deceleaza in cadranul infero-intern, corespunzator orei 5, la minim 7 cm de formatiunea tumorală antedescrisa, arie bruna (probabil hemoragie post punctie), cu o suprafata de 2 cm diametru, se afla la 2,5 cm de medial, 4,5 cm de superior, 3,5 cm de inferior, 1 cm de superficial, 1, 8 cm de profund; se include intreaga arie, in 7 blocuri de parafina

224454/31-33: arie bruna cu limita anterioara

Examinare microscopica:

1: Se identifica microscopica 4 limfoganglioni cu histiocitoza sinusala, un limfoganglion prezinta infiltrate tumorale ce masoara 8 mm - macrometastaza carcinomatoasa, cu extensie extranodala, sub 2 mm.

2: Fragmente de parenchim mamar cu fibroza si ducte dilatate, pe unul dintre fragmente (bl 5) se observa un duct cu imagini sugestive pentru carcinom ductal in situ cu aspect solid si grad nuclear II.

3: Se examineaza microscopica fragmente reprezentate de parenchim mamar ce prezinta in aria descrisa macroscopic, focar tumoral cu aspect de proliferare neoplazica maligna, cu dimensiuni maxime de 28/25 mm cu aspect de carcinom mamar invaziv de tip NST/ductal infiltrativ, la 9 mm se deceleaza mic focar de 7 mm, cu aceasi morfologie; cu pattern de crestere sub forma de insule, cuiburi si trabecule; constituite din celule neoplazice de talie medie, cu limite celulare indistincte, citoplasme eozinofile, pleomorfism nuclear moderat, indice mitotic de 10 mitoze/10HPF; dispuse intr-o stroma cu moderata desmoplazie, cu arii extinse de sclero-hialinizare si redus infiltrat inflamator cronic in stroma tumorală (TILs 1%); microcalcificari si necroza, prezente la nivel tumoral.

Proliferarea tumorală prezinta pe piesa de excizie grad histologic G2 (moderat diferentiat) - scor Nottingham 7: structuri tubulare sub 10% (3 puncte), pleomorfism nuclear moderat (2 puncte), activitate mitotica moderata (10 mitoze/10 HPF) (2 puncte).

Se identifica rare focare de carcinom ductal in situ, cu arhitectura solida sau cribriforma, grad nuclear II, unele cu necroza centrala, intra- si peritumoral, dar si la distanta - corespunzator sectiunilor recoltate de la ora 5 (intreaga zona a fost inclusa la parafina, nu se deceleaza focare invazive in cadranul infero-intern) - 25% din suprafata.

Se deceleaza invazie limfo-vasculara (LVI+) si infiltrare perineurala (Pn+).

Limite de excizie libere de elemente tumorale, limita anterioara se afla la minim 1 mm de cel mai apropiat focar de carcinom in situ. (RO).

Parenchim mamar cu fibroza, ectazii ductale, hiperplazie uzuala si metapalzie apocrina, modificare cu celule columnare si atipie plana, modificare fibroadenomatoida si adenoza.

4: Fragmente de parenchim mamar cu fibroza si ducte dilatate, arhitectura pastrata, cu ducte si lobuli tapetati de celule epiteliale non-atipice si strat mioepitelial pastrat - nu se deceleaza leziuni suspecte de malignitate in sectiunile examinate.

5: S-au identificat 20 limfoganglioni ce prezinta histiocitoza sinusala, fara determinari secundare decelate.

Examinare imunohistochimica:

AE1/AE3

224454/1: Reactie pozitiva citoplasmatica, de intensitate crescuta, difuza in proliferarea carcinomatoasa

224454/2: Reactie absenta in sectiunea examinata.

224454/14 sectiune formatiune tumorală

ER: Reactie pozitiva nucleara, de intensitate crescuta, in 95% din celulele tumorale invazive (scor Allred 8).

PR: Reactie pozitiva nucleara, de intensitate variabila, preponderent crescuta, in 45% din celulele tumorale invazive

(scor Allred 7).
 HER2(HER2/ neu; Roche - platforma Ventana): Reactie membranara completa, de intensitate redusa si moderata, peste 10% din celulele tumorale invazive (scor 2+) (echivoc).(ASCO-CAP 2018/2021-23).
 Ki67%: Reactie pozitiva nucleara in aproximativ 20% din celulele tumorale invazive. (ST. Gallen Consensus, 2015/2017)
 E-cadherin:Reactie pozitiva membranara, de intensitate crescuta, difuza in celulele tumorale invazive
 p63: Reactie absenta in componenta invaziva, prezenta in jurul structurilor benigne si a focarelor de carcinom in situ.
 Concluzii:
 1 : S-au identificat 4 limfoganglioni santinela, unul dintre ele cu macrometastaza carcinomatoasa de 8 mm, ENE + (sub 2 mm).
 2: Tesut retroareolar drept - pe sectiunile la parafina se intercepteaza un singur duct colonizat de carcinom ductal in situ, grad nuclear II si arhitectura solida.
 3: Piesa de mastectomie dreapta ce prezinta carcinom mamar invaziv multifocal, de tip NST (no special type/ductal), cu grad histologic G2 (moderat diferentiat) (scor Nottingham 7 =3+2+2); dimensiune maxima tumorală 28 mm; la 9 mm de acesta, in acelasi cadran, se deceleaza mic focar de 7 mm, cu aceeasi morfologie.
 Se asociaza carcinom ductal in situ, grad nuclear II, arhitectura cribriforma si solida, cu necroza centrala, localizat intratumoral, peritumoral si la distanta - 25% din suprafata.
 In aria corespunzatoare orei 5 (cadran infero-intern), se observa focare de carcinom ductal in situ cu aceeasi morfologie, fara invazie stromala, situate la minim 1 mm de limita anterioara.
 Invazie angio-limfatica prezenta (LVI+).
 Infiltrare perineurala prezenta (Pn+).
 Limite de excizie fara elemente tumorale (RO); minim 1 mm de la ultimul focar de DCIS la limita anterioara.
 Cod ICD-O/WHO: 8500/3.
 Stadializare pTNM: pT2(2), N1a, LVI+, Pn+, RO.
 Receptori hormonali: estrogenici 95%, progesteronici 45%; indice de proliferare celulara Ki67=20%;
 Her2 echivoc (scor 2+) (ASCO-CAP, 2018/2021-23) (surogat pentru subtip molecular luminal B).
 4: Piesa de mastectomie stanga fara imagini sugestive pentru malignitate, cu modificari fibro-chistice.
 5: Tesut limfoganglionar drept - s-au decelat 20 de limfoganglioni fara determinari secundare.
 Comentarii: Scorul echivoc al expresiei proteice Her2 impune evaluarea statusului genei Her2/neu prin hibridizare in situ.

Hibridizare in situ nr.226358 / Oncoteam / 18.03.2025

Hibridizare in situ (CISH, FISH, SISH):

Diagnostic anterior: Carcinom mamar invaziv, HER2 echivoc (scor 2+) - bloc intern nr 224454/14

Evaluare status test ISH pentru gena HER2/neu (SISH): Kit utilizat: HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail

Producator: Ventana

Platforma: Automatizata

Expresie in tesutul tumoral de evaluat: Raport nr mediu semnale HER2 per nucleu/nr mediu de semnale CEP17 per nucleu = 1,3 (2,8/2,15)

Raportul HER2/CEP17 a fost calculat in urma evaluarii a 20 de nuclei reprezentativi din ariile tumorale invazive.

Status TEST ISH pentru gena HER2/neu (SISH HER2):Statusul genei HER2/neu:

NEAMPLIFICAT/NEGATIV

(Raport HER2/CEP17<2, cu >=4 semnale dar <6 semnale HER2/celula - Grup 4)

Raportare conform ASCO-CAP 2023

BHP-IHC nr. 217158 / Oncoteam / 08.01.2025

Examinare macroscopica:

S-a receptionat 1 recipient cu formol 10% cu 7 fragmente tisulare, recoltate prin punctie biopsie, alb- galbui, cu dimensiuni cuprinse intre 0,1 si 0,8cm. Se prelucreaza in totalitate si se incluzioneaza materialul tisular in blocul de parafina cu nr 217158.

Examinare microscopica:

Bloc 217158:

Fragmente de tesut mamar, recoltate prin punctie biopsie , cu prezenta de relativ frecvente structuri ductale grupate si alaturate, cu proliferare intraductala, cu celule ovalare sau rotunde, cu nuclei de grad scazut si intermediar, cu citoplasma eozinofila, cu pattern arhitectural solid, cu arii de comedonecroza si relativ frecvente microcalcificari intraluminal.

Examinare imunohistochimica:

E caderina* pozitiv difuz in celulele cu nuclei de grad scazut si intermediar din proliferarea intraductala

ER pozitiv difuz (100%) in celulele cu nuclei de grad scazut si intermediar din proliferarea intraductala;

p63* pozitiv in celulele mioepiteliale periductal;

CK5/6* negativ in celulele cu nuclei de grad scazut si intermediar din proliferarea intraductala si pozitiv in celulele mioepiteliale periductal.

Concluzii:

Testele imunohistochimice corelate cu tabloul histopatologic si cu datele anatomoclinice pledeaza pentru diagnosticul de carcinom mamar ductal "in situ" ER pozitiv, cu grad nuclear scazut si intermediar, cu pattern arhitectural solid, cu arii de comedonecroza si relativ frecvente microcalcificari intraluminal -categorii diagnostice B5c-NHSBSP, EUSOMA.
 ICD O:8500/2

BHP-IHC nr.216121 / Oncoteam / 17.12.2024

Examinare macroscopica:

S-a receptionat 1 recipient cu formol 10% cu 5 fragmente tisulare alb-galbui, recoltate prin punctie biopsie, cu dimensiuni cuprinse intre 0,2 si 1,4cm; se prelucreaza in totalitate si se incluzioneaza materialul tisular in blocul de parafina cu nr 216121.

Examinare microscopica:

Bloc 216121:

Fragmente de tesut fibroadipos, recoltate prin punctie biopsie, cu infiltrare tumorală malignă carcinomatoasă, cu minim si moderat pleomorfism, alcatuita dintr-o proliferare cu celule rotunde sau ovalare, cu citoplasma eozinofila, nuclei ovalari, pe alocuri nucleolati, dispuse in insule, cuiburi sau travee, infiltrand o stroma cu marcata sclerozarea; relativ frecvente mitoze (aproximativ 7/10 campuri cu diametrul de 0,5mm); TILs (infiltrat limfocitar stromal tumoral) 1%; invazie limfovaculara inaparenta.

Examinare imunohistochimica:

E caderina* pozitiv difuz in celulele tumorale;

ER pozitiv aproximativ 95% in celulele tumorale;

PGR pozitiv aproximativ 35% in celulele tumorale ;;

Her2 pozitiv membranal complet, reactie de intensitate scazuta/moderata>10% in celulele tumorale (2+)-criterii ASO/CAP2023;

ki67 pozitiv aproximativ 20% in celulele tumorale;

p63* negativ.

Concluzii:

Testele imunohistochimice corelate cu tabloul histopatologic si cu datele anatomoclinice sunt compatibile cu diagnosticul de carcinom mamar invaziv NST (carcinom ductal invaziv NOS), moderat diferentiat, G2 (scor pentru grading histologic=7; Fc=3, A=2, M=2), ER pozitiv, PGR pozitiv si Her2 echivoc (2+)-categorie diagnostica B5b-NHSBSP, EUSOMA.

ICD O:8500/3

Hibridizare in situ (CISH, FISH, SISH)

Bloc 216121:

HER2neu dispuse individual si in aglomerar mici, cu o medie de semnale ISH HER2neu de 5,4/per nucleu, cu prezenta de 1-6 copii ale cromozomului 17(Chr17) per nucleu si raport intre semnalele

Her2neu si Chr 17< 2 /pe 20 de celule tumorale indicand neamplificarea genei.

Concluzii:

Reactie Dual ISH pentru evaluarea statusului genei HER2 neu negativa.

NL: 1) Se recomanda interpretarea rezultatului in context anatomoclinic.

2) Polisomie prezent

Recomandari

Oncotype DX

RT dupa vindecarea plagii operatorii

initiere HT

Se va stabili conduita terapeutica ulterioara in functie de rezultatul Oncotype

Prof. Univ. Dr. Rodica Anghel
medic primar radioterapie oncologica
medic primar oncologie medicala
Cod 27496

Prof. Dr. Rodica Anghel
Profesor
Oncologie Medicala